



MEMORANDO CIRCULAR Nº 06/2025/SMS/SAB Santa Maria, 08 de dezembro de 2025.

De: Política de Alimentação e Nutrição e Política das Doenças e Agravos Não Transmissíveis

Para: Unidades de Atenção Primária à Saúde

Assunto: Fluxo atualizado de encaminhamento do usuário com obesidade candidato à cirurgia Bariátrica

Considerando o que é previsto na portaria MS Nº 424 de 2013 – que refere as diretrizes gerais para o tratamento da obesidade. Conforme portaria as indicações para cirurgia bariátrica são:

- a. Indivíduos que apresentem IMC 50 Kg/m²;
- b. Indivíduos que apresentem IMC 40 Kg/m², com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado, na Atenção Básica e/ou na Atenção Ambulatorial Especializada, por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos;
- c. Indivíduos com IMC > 35 kg/m² e com comorbidades, tais como pessoas com alto risco cardiovascular, Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle, apneia do sono, doenças articulares degenerativas, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos.

Considerando a aprovação na última Comissão Intergestores Regional (CIR), na data de 25 de novembro de 2025, será imprescindível a utilização do documento em anexo para acesso à fila de cirurgia bariátrica no GERCON.

Por isso, ressalta-se que o tratamento e acompanhamento em questão deve ser voltado à obesidade, e não a outras comorbidades/doenças associadas.

Os seguintes critérios devem ser observados:

- I. Indivíduos que não responderam ao tratamento clínico longitudinal, que inclui orientação e apoio para mudança de hábitos, realização de dieta, atenção psicológica, prescrição de atividade física e, se necessário, farmacoterapia, realizado na Atenção Básica e/ ou Atenção Ambulatorial Especializada por no mínimo dois anos e que tenham seguido protocolos clínicos;
- III. O indivíduo e seus responsáveis devem compreender todos os aspectos do tratamento e assumirem o compromisso com o segmento pós-operatório, que deve ser mantido por tempo a ser determinado pela equipe;
- IV. Compromisso consciente do paciente em participar de todas as etapas da programação, com avaliação pré-operatória rigorosa (psicológica, nutricional, clínica, cardiológica, endocrinológica, pulmonar, gastroenterológica e anestésica).

PORTANTO, A PARTIR DA DATA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 O USO DO DOCUMENTO PARA ACESSO À CIRURGIA BARIÁTRICA SERÁ OBRIGATÓRIO.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA EVANIR VICENTE FERREIRA
Data: 08/12/2025 16:41:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIANE DE OLIVEIRA MILANI
Data: 09/12/2025 09:30:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enf. Maria Evanir Vicente Ferreira
Política das Doenças Crônicas não Transmissíveis

Nutricionista Mariane de Oliveira Milani
Política de Alimentação e Nutrição

**DECLARAÇÃO DE PLANO TERAPÊUTICO PARA PACIENTES COM
OBESIDADE**

(Indivíduos com IMC entre 35 a 45 kg/m²)

Nome do paciente: _____ **Data de nascimento:** _____

Data do início do tratamento para obesidade (consulta 1): _____

Peso inicial: _____ IMC: _____ CA: _____

Data consulta 2: _____ Peso consulta 2: _____ IMC: _____ CA: _____

Data consulta 3: _____ Peso consulta 3: _____ IMC: _____ CA: _____

Data consulta 4: _____ Peso consulta 4: _____ IMC: _____ CA: _____

Data consulta 5: _____ Peso consulta 5: _____ IMC: _____ CA: _____

Data consulta 6: _____ Peso consulta 6: _____ IMC: _____ CA: _____

Data consulta 7: _____ Peso consulta 7: _____ IMC: _____ CA: _____

Data da última consulta na unidade de referência (consulta 8): _____

Peso final: _____ IMC: _____ CA: _____

Estratégias adotadas no tratamento para obesidade:

() Prescrição de exercícios físicos

() Mudanças de hábitos alimentares

() Apoio familiar

() Ações intersetoriais

() Grupos terapêuticos

() Aconselhamento em Saúde

() Entrevista motivacional

() Terapia Cognitiva Comportamental

() Autocuidado Apoiado

() Atendimento Multiprofissional (além da equipe da APS). Quais profissionais?

() Nutricionista () Educador Físico () Psicólogo

Outros: _____

Diretrizes, materiais e protocolos clínicos utilizados:

Tratamento farmacológico:

() Não () Sim. Quais? _____

Comorbidades desenvolvidas ou associadas à obesidade:

- () DM II
- () HAS
- () Doenças cardiovasculares
- () Doença cardiopulmonar leve a moderada
- () Doenças osteomusculares
- () Dificuldades na deambulação
- () Doenças hormonais e/ou reprodutivas
- () Doenças gastrointestinais
- () Problemas dermatológicos
- () Dislipidemias

Atesto para os devidos fins que o paciente referido não respondeu ao tratamento clínico longitudinal, que inclui orientação e apoio para mudança de hábitos, realização de dieta, atenção psicológica, prescrição de atividade física e, se necessário, farmacoterapia, **realizado na Atenção Básica e/ ou Atenção Ambulatorial Especializada, segundo protocolos clínicos.**

Assinatura Médico

Assinatura Multiprofissional
(Nutricionista, Enfermeiro, Educador Físico, Psicólogo, etc.)